TEMA 15 · Comunicación, relación de ayuda y entrevista clínica. Demografía sanitaria e indicadores demográficos

Resumen OPE Enfermería SMS · Bloque A: Comunicación, asertividad, Peplau, relación de ayuda, trabajo en equipo, entrevista clínica y motivacional, escalas de apoyo y sobrecarga · Bloque B: Demografía estática y dinámica, indicadores, índices de envejecimiento, cronicidad y equidad

A1. Fundamentos de la comunicación

- **"Es imposible no comunicar"**. Regla de **Mehrabian** (impacto emocional): **verbal 7%**, **paraverbal 38%** (tono, volumen, ritmo, pausas), **no verbal 55%**. Ante una incongruencia, se cree al mensaje **no verbal**.
- **Kinesia** (gestos, postura, mirada; inclinarse hacia delante = interés), **paralingüística** (silencios terapéuticos) y **proxémica (Edward T. Hall)**:

Distancia	Rango	Uso
Íntima	**0-45 cm**	Procedimientos (higiene, curas): pedir permiso; invadirla sin aviso en pacientes agitados o con demencia provoca agresividad
Personal	**45 cm-1,20 m**	**Entrevista clínica**, valoración, educación individual
Social	1,20-3,60 m	Mostradores, interacciones formales
Pública	> 3,60 m	Charlas y educación grupal

- **Barreras**: físicas (ruido, interrupciones), psicológicas (prejuicios, negación), **semánticas** (tecnicismos) y fisiológicas (hipoacusia, afasia). Facilitador principal: **escucha activa**.
- **Ventana de Johari (Luft e Ingham)**: área **abierta** (conocida por uno y por los demás), **ciega** (los demás la ven, uno no: se reduce con **feedback**), **oculta** (uno la conoce y la esconde: se reduce con **autoexposición**) y desconocida. Objetivo: ampliar el área abierta.

A2. Asertividad

- Estilos: **pasivo** (prioriza al otro), **agresivo** (pisa los derechos ajenos) y **asertivo** (defiende los propios derechos respetando los del otro).

Técnica	En qué consiste
Disco rayado	**Repetir** con calma el mismo mensaje o límite, sin entrar en provocaciones
Banco de niebla (*fogging*)	**Dar la razón en parte** ("es posible que tenga razón…") sin cambiar la postura
Aserción negativa	Reconocer un error real de forma breve, sin autohumillarse
Interrogación negativa	Pedir detalles ante una crítica genérica ("¿qué te molesta exactamente?")
Asertividad empática	Validar primero el sentimiento del otro y después marcar el límite
Mensajes yo (Thomas Gordon)	Describir la conducta objetiva → expresar el sentimiento → consecuencia → propuesta de cambio (frente al acusatorio "mensaje tú")

A3. Hildegard Peplau (1952): relaciones interpersonales

Fase	Contenido	Equivale en el PAE
Orientación	El paciente busca ayuda; se clarifica el problema y se crea confianza	Valoración y diagnóstico
Identificación	El paciente se identifica con quien le ayuda; se fijan metas	Planificación
Explotación (aprovechamiento)	Saca el máximo partido a los servicios; asume control	Ejecución

Fase	Contenido	Equivale en el PAE
Resolución	Necesidades satisfechas; se disuelve la relación y se logra independencia	Evaluación y alta

- **6 roles**: extraño, persona recurso, docente, líder, sustituto (transferencia) y **consejero**, el **de mayor importancia** según Peplau. Peplau, "madre de la enfermería psiquiátrica".

A4. Relación de ayuda

- Intervención deliberada y temporal para que la persona **movilice sus propios recursos**; no es compadecer ni dar consejos paternalistas.
- **Carl Rogers** (terapia centrada en el cliente): **aceptación positiva incondicional**, **empatía** (comprender "como si" fuera propio, sin perder el "como si") y **congruencia o autenticidad**. La **simpatía** (contagio emocional) es antiterapéutica y favorece el burnout.
- **Robert Carkhuff** (modelo de destrezas, entrenable): fases de **exploración → comprensión → acción**. Respuestas no facilitadoras: **detective** (interroga), **juez** (evalúa y moraliza), **sargento** (ordena), **florista** (falso consuelo: "todo saldrá bien"), mago (adivina) y etiquetador.
- **Chalifour**: relación de ayuda integrada en todo el PAE; **cuidados invisibles**. **Escuela española (Luis Cibanal y Diego José Ibáñez, Alicante)**: la comunicación **tiene valor terapéutico** ("la comunicación ayuda a curar"), enfoque sistémico (paciente y familia).

TRAMPAS DE EXAMEN

! Ante un paciente que llora, la respuesta correcta es **estar presente, escuchar y acompañar**, nunca "no se preocupe, todo saldrá bien" (florista).

A5. Trabajo en equipo

- **Grupo** (tareas independientes) frente a **equipo** (objetivo común, interdependencia, responsabilidad compartida).
- **Multidisciplinar** (disciplinas en paralelo, comunicación escrita), **interdisciplinar** (plan único y objetivos compartidos, sesiones conjuntas; aspiración de la AP) y **transdisciplinar** (fronteras difuminadas, el paciente forma parte del equipo, ***role release***).

Tuckman (1965; 1977)	
Formación (*forming*)	Cortesía, incertidumbre, dependencia del líder
Conflicto (*storming*)	Luchas de poder; fase dolorosa pero necesaria
Normalización (*norming*)	Cohesión, roles y normas
Desempeño (*performing*)	Máximo rendimiento y autonomía
Disolución (*adjourning*, 1977)	Fin del equipo, duelo

- **SBAR / SAER** (traspasos y llamadas): **Situación**, **Antecedentes**, **Evaluación** (incluye el **juicio clínico** de la enfermera, no solo las constantes) y **Recomendación** (propuesta concreta de acción).
- **Thomas-Kilmann** (asertividad × cooperación): **competitivo** (gano/pierdes; **útil en una RCP**), acomodaticio, evitativo, compromiso (partir la diferencia) y **colaborativo** (gano/ganas; el ideal en el día a día).

A6. Entrevista clínica (Borrell) y entrevista motivacional

- Entrevista clínica: encuentro estructurado con propósito (inicio, desarrollo, cierre), roles asimétricos y secreto profesional.
- **Borrell**: fase **exploratoria** (recabar información) y fase **resolutiva** (informar, proponer y **negociar**). Habilidades **instrumentales** (el "qué": tipos de preguntas, resúmenes) e **interaccionales** (el "cómo": calidez, empatía, silencios).

- Técnicas: saludo cordial (**marcador de clima**), preguntas abiertas, **vaciado de la información preelaborada** (dejar hablar sin interrumpir al inicio) y prevención del **síndrome del picaporte** ("¿hay algo más que le preocupe hoy?"). Si aparece al final, valorar la gravedad: si es urgente, se atiende.
- **Entrevista motivacional (Miller y Rollnick, 1991)**: resolver la **ambivalencia**; la motivación es un estado modificable. Fase diana: **contemplación**. La **recaída** forma parte del ciclo (sin culpabilizar).
- **4 principios**: expresar **empatía**, **desarrollar la discrepancia** (conducta frente a valores), **rodar con la resistencia** (no confrontar) y **apoyar la autoeficacia**. Técnicas **OARS**: preguntas abiertas, afirmaciones, **escucha reflexiva** (núcleo de la técnica) y resúmenes.

A7. Escalas de valoración del apoyo emocional y social

Escala	Mide	Puntuación y cortes
Zarit (22 ítems)	**Sobrecarga del cuidador**	Versión española (1-5 por ítem): **< 47 sin sobrecarga**, **47-55 leve**, **> 55 intensa**. **Abreviada de 7 ítems: ≥ 17** = sobrecarga
Duke-UNC-11	**Apoyo social funcional percibido** (subjetivo)	11 ítems (11-55); dimensiones **confidencial** y **afectiva**; **a menor puntuación, menor apoyo** (≤ 32 apoyo escaso, según el manual)
Apgar familiar (Smilkstein, 1978)	Funcionalidad familiar percibida	5 ítems (0-2): Adaptabilidad, Participación, Crecimiento (*Growth*), Afecto, Resolución. **7-10 normofuncional**, **4-6 disfunción leve**, **0-3 grave**
HAD (Zigmond y Snaith)	**Ansiedad y depresión en pacientes no psiquiátricos**	14 ítems (7 + 7); **excluye síntomas somáticos**; cada subescala **0-7 normal, 8-10 dudoso, ≥ 11 caso**
Escala de Gijón	Situación **sociofamiliar** del mayor	5 áreas (5-25): **5-9 normal**, **10-14 riesgo social**, **≥ 15 problema social**
Yesavage (GDS-15)	Depresión geriátrica	Sí/No; **0-4 normal**, 5-9 depresión leve, ≥ 10 establecida

BLOQUE B · Demografía sanitaria

B1. Conceptos, transiciones y demografía estática

- La demografía aporta el **denominador** de las tasas y es la base del **Análisis de Situación de Salud (ASIS)** y de la asignación de cupos (TSI).
- **Transición demográfica (Notestein, 1945)**: de alta natalidad y mortalidad a baja natalidad y mortalidad. **Transición epidemiológica (Omran, 1971)**: de enfermedades infecciosas a **crónicas** y degenerativas.
- **Demografía estática** ("fotografía"): dimensión, territorio y estructura (edad y sexo).

	Censo	**Padrón**
Responsable	**INE**	**Ayuntamientos** (coordina el INE)
Periodicidad	Decenal (años terminados en 1)	**Continua**
Carácter	Estadístico, **secreto estadístico**	Administrativo y **público**; prueba de residencia; necesario para la **TSI**

- **Población de hecho** = residentes presentes + **transeúntes**. **Población de derecho** = residentes presentes + **residentes ausentes**.
- Encuestas: **ENSE** (Ministerio de Sanidad e INE) y **Encuesta Europea de Salud** (cada 5 años, Eurostat).
- **Pirámide**: edades en el eje vertical, hombres a la **izquierda** y mujeres a la derecha. Pagoda o expansiva (joven), campana o estacionaria y **bulbo, urna o regresiva** (España y Murcia; el "abultamiento" de **50-70 años** es el ***baby boom***, que llegará a los 65 en la próxima década).

B2. Demografía dinámica

- Fuentes: **Registro Civil** → **Movimiento Natural de la Población (INE)**.
- **Ecuación compensadora**: P1 = P0 + N − D + I − E. **Crecimiento vegetativo = N − D** (negativo en España y Murcia). **Saldo migratorio = I − E**. **Crecimiento real = CV + SM**: puede ser positivo con CV negativo si la inmigración lo compensa.
- **Proporción** (el numerador está en el denominador), **razón** (no lo está: razón de masculinidad) y **tasa** (incluye el tiempo).

Indicador	Cálculo
Tasa bruta de natalidad	Nacidos vivos / población total × 1.000
Tasa de fecundidad general	Nacidos vivos / **mujeres de 15-49 años** × 1.000
Índice sintético de fecundidad	Hijos por mujer; **reemplazo: 2,1** (España ≈ 1,1-1,2)
Tasa bruta de mortalidad	Defunciones / población media × 1.000 (alta en países envejecidos)
Mortalidad específica	Denominador: **solo el subgrupo** (p. ej., varones de 40-44 años)
Mortalidad infantil	Muertes < 1 año / **nacidos vivos** × 1.000
Mortalidad materna	Muertes por embarazo, parto o puerperio / **nacidos vivos** × **100.000**

- **Neonatal**: < 28 días (**precoz < 7 días**, causas endógenas y obstétricas; tardía 7-27 días). **Postneonatal**: 28 días a < 1 año (causas **exógenas**: infecciones, accidentes; la más sensible a la enfermería comunitaria).
- **Mortalidad perinatal**: en España (**INE**) muertes fetales desde las **28 semanas** + muertes en los **primeros 7 días**; la OMS la inicia en las **22 semanas** (o ≥ 500 g); la "ampliada" llega hasta los 28 días.
- **Esperanza de vida al nacer**: indicador **transversal e hipotético** (tasas del año), no una predicción. **EVLI** (libre de incapacidad): a los 65 años es ligeramente mayor en varones en España (0,1 años).

B3. Índices de estructura

Índice	Fórmula	Interpretación
Envejecimiento	Mayores / jóvenes × 100	> 100 = más mayores que jóvenes. Murcia superó el 100% en 2025 (102,7%); España ≈ 148% (según el manual)
Dependencia global	(< 15 + ≥ 65) / **15-64** × 100	Denominador **siempre la población activa**; España ≈ 53
Dependencia senil	≥ 65 / 15-64 × 100	
Generacional de ancianidad	**35-64 / ≥ 65** × 100	Si baja, **menos cuidadores potenciales**
Sundbärg	< 15 frente a ≥ 50 (base 15-49)	Vieja si ≥ 50 > < 15
Fritz	0-19 / 30-49 × 100	> 160 joven; 60-160 madura; **< 60 vieja**
Burgdöfer	5-14 frente a 45-64	**Vieja si 5-14 < 45-64**

B4. Envejecimiento, cronicidad y equidad

- **Fries**: **compresión de la morbilidad** (concentrar la discapacidad al final de la vida) frente a expansión (más años con enfermedad).
- **Paciente pluripatológico**: ≥ 2 enfermedades crónicas, inestabilidad, síndromes geriátricos, polifarmacia, "puerta giratoria".
- **Longitudinalidad**: el mismo profesional a lo largo de la vida. **Continuidad asistencial**: coordinación entre niveles (AP, hospital, sociosanitario).

Pirámide de Kaiser Permanente	Población	Intervención
Nivel 1 (base)	70-80%	Promoción y prevención, autocuidado
Nivel 2	15-20% (crónicos de baja complejidad)	**Gestión de la enfermedad** (*disease management*), EpS grupal
Nivel 3 (cúspide)	**3-5%** (crónico complejo; > 50% de los recursos)	**Gestión de casos** (*case management*): **enfermera gestora de casos**

- Enfermera gestora de casos: captación proactiva (listados de estratificación GMA), valoración geriátrica integral, enlace de recursos, alta compleja y atención al cuidador (Zarit).
- **Igualdad** (lo mismo para todos) frente a **equidad** (a cada cual según su necesidad). **Desigualdad**: cualquier diferencia medible (puede ser biológica). **Inequidad**: desigualdad **sistemática, evitable e injusta**.
- **Curva de Lorenz** y **coeficiente de Gini**: **0 = igualdad perfecta**, **1 = desigualdad máxima**.
- **Dahlgren y Whitehead**: núcleo (edad, sexo, genética), capa 1 (estilos de vida), **capa 2 (redes sociales y comunitarias: familia, soledad)**, **capa 3 (condiciones de vida y trabajo, incluido el sistema sanitario)**, capa 4 (condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales).

TRAMPAS DE EXAMEN

! Disco rayado = **repetir**; banco de niebla = **dar parte de razón** sin ceder.

! **Población de derecho = presentes + ausentes; de hecho = presentes + transeúntes.**

! **Mortalidad infantil y materna: denominador nacidos vivos (la materna, × 100.000).**

! Las tasas de dependencia tienen como denominador la población de **15-64 años**.